

IPV (Salk): Ενέσιμο ενισχυμένο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας.

Τριδύναμο εμβόλιο με μίγμα νεκρών ιών, από τους 3 ορότυπους (1,2,3) ιού πολιομυελίτιδας. Περιέχει μικρές ποσότητες στρεπτομυκίνης και νεομυκίνης. Φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

- * Σε άτομα με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια, καθώς και σε παιδιά που στο άμεσο περιβάλλον τους υπάρχουν τέτοια ανοσοκατεσταλμένα άτομα.
- * Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί και πρόκειται να ταξιδέψουν σε επιδημικές περιοχές ή άτομα που εργάζονται σε εργαστήρια με καλλιέργειες του ιού ή υπάλληλοι σε ειδικές υπηρεσίες (υγειονομικό προσωπικό) ή άτομα που διαβιούν σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.
- * Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον υποπτευόμαστε πιθανή έκθεση στη νόσο.

M-M-R (Priorix): Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς.

- * Χορηγείται στην ηλικία των 12-15 μηνών.
- * Συνιστάται η 2^η δόση του εμβολίου να πραγματοποιείται σε ηλικία 4-6 ετών, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία, αρκεί να απέχει 2 μήνες από την 1^η δόση.
- * Ο παιδίατρος ή ο οικογενειακός ιατρός πρέπει να ελέγχει αν έγινε ή όχι η 2^η δόση και αν όχι, τότε χορηγείται η 2^η δόση σε οποιαδήποτε ηλικία.
- * Σε περίπτωση έκθεσης στην ιλαρά, το εμβόλιο μπορεί να προλάβει την εμφάνιση νόσου, εφόσον διενεργηθεί στις τρεις πρώτες ημέρες μετά την έκθεση στον ιό.
- * Όλοι οι επίνοσοι ενήλικες λαμβάνουν 2 δόσεις του εμβολίου. Τα άτομα που γεννήθηκαν πριν το 1970 θεωρούνται άνοσα. Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970, θα πρέπει να έχουν εμβολιασθεί με 2 δόσεις MMR, εκτός αν υπάρχει αντένδειξη ή επιβεβαιωμένη ανοσία.
- * Δεν χορηγείται σε πάσχοντες από HIV με σοβαρή ανοσοκαταστολή ($CD_4 < 200/\mu L$). Δεν χορηγείται επίσης στην κύηση, ενώ η κύηση επιτρέπεται μετά ένα μήνα και πλέον από τον εμβολιασμό. Τυχαία χορήγηση σε έγκυο δεν συνιστά λόγο διακοπής της κύησης. Μπορεί να μειώσει τη διαγνωστική αξία της δοκιμασίας Mantoux. Δέον είναι να παρεμβάλλονται 3 μήνες εφόσον έχει προηγηθεί χορήγηση γ-σφαιρίνης ή μετάγγιση αίματος.

Το MMR είναι ασφαλές εμβόλιο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του είναι ήπιες και παροδικές.

- ▶ **Πυρετός.** Υπερπυρεξία (έως $\Theta > 39,5^\circ C$) παρουσιάζεται στο 5-15% των εμβολιαζόμενων. Ο πυρετός εμφανίζεται συνήθως 5 έως 12 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και μπορεί να διαρκέσει για 1-3 ημέρες. Σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει και 5 ημέρες. Στο 5% των περιπτώσεων συνοδεύεται από παροδικό εξάνθημα.
- ▶ **Σπασμοί.** Οι σπασμοί, εφόσον εκδηλωθούν, είναι απλοί πυρετικοί, δεν προδιαθέτουν σε επιληψία και δεν προκαλούν εγκεφαλική βλάβη.
- ▶ **Αλλεργικές αντιδράσεις.** Αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι σπάνιες και περιορίζονται σε δερματικές εκδηλώσεις στο σημείο της ένεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αλλεργία είναι επιβραδυνόμενου τύπου, οπότε το εμφανιζόμενο εξάνθημα – *ποικίλης μορφολογίας* – εμφανίζονται 48-96 ώρες μετά τον εμβολιασμό για MMR.
- ▶ **Θρομβοκυτταροπενία.** Η συχνότητα εμφάνισης ποικίλει στις διάφορες κλινικές μελέτες από 1 περίπτωση ανά 25.000, έως 1 περίπτωση ανά 10^6 δόσεις. Στα υγιή παιδιά είναι παροδική, αυτοϊώμενη και σπανίως συνοδεύεται από κλινικές εκδηλώσεις. Συχνότερα εμφανίζουν κλινικές εκδηλώσεις τα παιδιά με ιστορικό θρομβοπενικής πορφύρας. Παρότι ο κίνδυνος μετά από φυσική νόσηση είναι σαφώς μεγαλύτερος, όταν αναφέρεται πρόσφατο επεισόδιο θρομβοπενίας, ο εμβολιασμός είναι φρόνιμο να αναβάλλεται.

Δεν έχει αποδειχθεί η σχέση του εμβολίου MMR με εγκεφαλίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barré, νόσο του Crohn, αυτισμό ή υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα, νοσήματα για τα οποία κατά καιρούς είχε ενοχοποιηθεί από διάφορες αντιεμβολιαστικές ομάδες.